TALLO DE REVISIÓN
VIZION

TÉCNICA QUIRÚRGICA



SISTEMA FEMORAL MODULAR NO CEMENTADO

Medacta International

ÍNDICE

01 Fundamentos clínicos 3

02 Preparación femoral 6

03 Implantación definitiva in vivo 15

04 Implantación con dispositivo de mesa 23

05 Nomenclatura de implantes 28

06 Esterilización y aviso profesional 37

07 Trazabilidad del documento 39

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Indicaciones, planificación y acceso femoral

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Introducción

El tallo de revisión Vizion es un sistema femoral modular no cementado fabricado en aleación de titanio. Se compone de un cuerpo proximal y un tallo distal. Los cuerpos proximales se ofrecen en versiones sin orificios y con tres orificios; estos últimos permiten complementar la fijación del trocánter mayor mediante cables.

Indicaciones

Artroplastia total o parcial de cadera, primaria o de revisión, ante artrosis dolorosa e incapacitante, artritis traumática, poliartritis reumatoide, displasia congénita, necrosis avascular, fractura traumática de cabeza o cuello femoral y fracaso de cirugía previa. En artroplastia parcial: fractura o pseudoartrosis del cuello, necrosis avascular u otra patología de la cabeza femoral con acetábulo conservado.

Contraindicaciones

Infección aguda, crónica, local o sistémica; inmadurez esquelética; insuficiencia muscular, neurológica o vascular grave; calidad ósea que impida la estabilidad del implante; trastornos mentales o neurológicos que comprometan el cumplimiento posoperatorio. Deben investigarse antecedentes de alergia a los materiales del implante.



Configuración modular: cuerpo proximal acoplado al tallo distal.



Unión cónica entre los componentes proximal y distal.

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Planificación preoperatoria

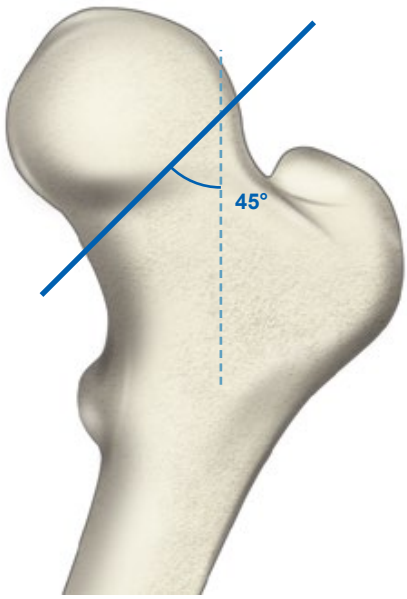
Utilice radiografías y plantillas del sistema para estimar los tamaños proximal y distal, el centro de rotación, el nivel de osteotomía y el diámetro de cabeza. La selección definitiva se confirma durante la cirugía de acuerdo con la anatomía y la estabilidad obtenida.

Abordaje y osteotomía

- El abordaje queda a criterio del cirujano. En cirugía primaria, realice la osteotomía cervical aproximadamente a 45° respecto del eje diafisario y retire la cabeza femoral. En revisión, retire el implante previo y, cuando corresponda, el cemento mediante instrumental de extracción apropiado.

Acceso al canal femoral

Exponga el eje diafisario. Abra el canal con cincel tipo caja en el lado opuesto a la fosa digital, con ligera anteversión. Puede emplearse el cincel angulado ref. 01.15.10.0224. Mantenga el eje del escariador alineado con el eje femoral.



PLANO DE OSTEOTOMÍA: 45° RESPECTO DEL EJE FEMORAL.



Cincel tipo caja: apertura axial del canal femoral.

PREPARACIÓN FEMORAL

Fresado, componentes de prueba y reducción

PREPARACIÓN FEMORAL

Fresado distal

- Prepare el canal con escariadores distales hasta el diámetro planificado o hasta obtener contacto cortical. Los diámetros progresan de 12 a 28 mm en incrementos de 1 mm. Los tallos de 180 y 220 mm utilizan escariador largo; los tallos de 140 mm y diámetros 12 a 15 mm requieren escariador corto. Los demás tallos de 140 mm utilizan escariador largo.

Profundidad y control

Fresado manual con mango en T hasta la marca prevista, habitualmente a la altura del vértice del trocánter mayor. Confirme la profundidad por sensación y sonido de contacto cortical, presencia de hueso cortical en el escariador y, si es necesario, fluoroscopia o radiografía.

Precaución sobre la calidad ósea

Valore cuidadosamente el uso de escariadores distales en hueso comprometido. El implante definitivo es ligeramente mayor que el escariador para generar ajuste a presión y estabilidad primaria. Las marcas del escariador indican la altura del cuerpo proximal y, con cabeza M, el centro de la cabeza.



Fresado distal manual con mango en T hasta la marca prevista.



Escariador distal: seleccione longitud y diámetro planificados.

PREPARACIÓN FEMORAL

Prueba del componente distal

- Seleccione el tallo distal de prueba del mismo diámetro que el último escariador. Introduzca la varilla en el insertor/extractor, rosque el conjunto al tallo y ajuste con el destornillador corto de 3,5 mm. Dé una vuelta adicional al cabezal de bloqueo. La línea de control visible en la ventana confirma el montaje correcto.

Inserción y evaluación de estabilidad

Introduzca el tallo de prueba hasta la marca de profundidad obtenida en el fresado. Las marcas del insertor/extractor corresponden a las alturas de los cuerpos proximales. Verifique estabilidad axial y rotacional, registre la relación con el trocánter mayor y retire la varilla y el insertor/extractor.



Tallo distal de prueba acoplado al insertor/extractor.



Monte la varilla y asegure el conjunto con el destornillador.



Conjunto de prueba listo para inserción en el canal.



Línea de control visible: el montaje es correcto.

PREPARACIÓN FEMORAL

Opciones de prueba y extracción

El montaje puede prepararse verticalmente sobre la mesa. También puede utilizarse el tallo distal definitivo como prueba, siguiendo la misma técnica. Si es necesario extraer el componente, conecte el cuerpo extractor a la varilla y utilice el cilindro deslizante. Instrumental compatible: ref. 01.34S.402.



Conecte el extractor antes de retirar el componente de prueba.



Accione el cilindro deslizante sobre el eje del tallo.

PREPARACIÓN FEMORAL

Fresado proximal

- Rosque la varilla al tallo distal sin flexionarla. Deslice el escariador proximal sobre la varilla y avance siguiendo el eje femoral hasta su asentamiento completo. Frese manualmente con mango en T al diámetro seleccionado. Retire el escariador y deje la varilla unida al tallo.

Control de montaje

La línea marcada en la varilla debe quedar visible dentro de la ventana del escariador proximal; esta referencia confirma que los componentes del instrumental están correctamente ensamblados.



Rosque la varilla guía al tallo distal sin flexionarla.



Deslice el escariador proximal siguiendo el eje femoral.



Escariador proximal montado sobre la varilla guía.



Frese manualmente hasta el asentamiento completo.



Marca visible en la ventana: ensamblaje correctamente asentado.

PREPARACIÓN FEMORAL

Prueba del cuerpo proximal

- Limpie y seque la unión cónica del tallo de prueba. Seleccione la altura, el diámetro y el offset del cuerpo proximal de prueba. Acóplelo al tallo distal y ajuste la anteversión. La camisa plástica del cuerpo de prueba permite acoplarlo también a un tallo distal definitivo sin dañar el cono.

Fijación del conjunto de prueba

Introduzca el tornillo de bloqueo de prueba con el destornillador. Este tornillo es más corto que el definitivo y no posee recubrimiento superficial.



Seleccione el cuerpo proximal de prueba planificado.



Introduzca el tornillo de bloqueo de prueba.



Acople el cuerpo proximal al tallo distal de prueba.



Ajuste el tornillo de prueba con el destornillador.

PREPARACIÓN FEMORAL

Reducción de prueba

- Seleccione una cabeza de prueba del diámetro y la longitud adecuados y presiónela sobre el cono. Tras colocar el componente acetabular de prueba o definitivo, reduzca la articulación con ayuda del impactor de cabeza. Evalúe movilidad, estabilidad y longitud del miembro. Retire la cabeza traccionando de ella.

Reposicionamiento proximal

Si debe corregirse la anteversión, el offset o la longitud, retire el tornillo de prueba y desacople el cuerpo proximal. Repita la prueba con otro componente hasta lograr el equilibrio deseado.



Coloque la cabeza femoral de prueba sobre el cono.



Asegure el componente proximal antes de la reducción.



Compruebe longitud, offset, movilidad y estabilidad articular.



Retire el tornillo para corregir la posición proximal.

PREPARACIÓN FEMORAL

Desacople asistido

Si el cuerpo proximal queda trabado, rosque el mango del cuerpo proximal. Introduzca la herramienta de desmontaje y gírela en sentido horario; la herramienta se apoya contra la varilla de desmontaje y separa el cuerpo proximal del tallo distal.

Revisión del calcar

Inspeccione la preparación femoral, especialmente la región del calcar. Si existe interferencia, complete la preparación con cureta, pinza gubia o cincel antes de repetir la prueba.



Retire la cabeza de prueba antes del desacople.



Rosque la herramienta de desmontaje en el cuerpo proximal.



Monte el sistema de desacople sobre la varilla.



Separe el cuerpo proximal del tallo distal.



Gire la herramienta en sentido horario para desacoplar.



Mantenga el conjunto alineado durante la separación.

PREPARACIÓN FEMORAL

Retiro de los componentes de prueba

- Cuando la reducción sea satisfactoria, retire el tornillo y el cuerpo proximal. Deslice la varilla por el insertor/extractor, acóplelos al tallo distal y ajuste con el destornillador de 3,5 mm. Extraiga el tallo golpeando el yunque del insertor/extractor.

Extracción alternativa

Cuando se requiera mayor fuerza, conecte el cuerpo extractor a la varilla mediante el tornillo y utilice el cilindro deslizante.



Acople el insertor/extractor al tallo distal de prueba.



Extraiga el tallo golpeando axialmente sobre el yunque.



Desmonte la conexión después de retirar el componente.



Prepare la varilla para una extracción alternativa.



Conecte el cuerpo extractor cuando se requiera mayor fuerza.



Utilice el cilindro deslizante manteniendo el eje femoral.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO

Acople modular, bloqueo y reducción final

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO

Implantación definitiva in vivo

Implante el componente distal definitivo siguiendo la secuencia del tallo de prueba. Inspeccione visualmente el implante: no debe presentar rayas, indentaciones ni daños superficiales que puedan comprometer su resistencia. Limpie, irrigue y seque cuidadosamente ambas superficies de la unión cónica; si detecta daño, reemplace el componente.

Acople del cuerpo proximal

- Conecte el mango al cuerpo proximal y deslice el conjunto sobre la varilla roscada sin dañar la microtextura del cono. Ajuste la anteversión e impacte suavemente en sentido axial. La línea láser del mango indica el centro de una cabeza M y puede alinearse con el vértice del trocánter mayor. Si queda demasiado proximal, revise el calcar.



Rosque la varilla en el tallo distal definitivo.



Introduzca el tallo definitivo hasta la profundidad planificada.



Deslice el cuerpo proximal sin dañar la unión cónica.



Compruebe la reducción con una cabeza femoral de prueba.



Ajuste la anteversión del cuerpo proximal.



Impacte suavemente el cuerpo proximal en sentido axial.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO - SECUENCIA VISUAL



Mantenga la varilla roscada durante el acople definitivo.



Verifique nuevamente longitud, offset y estabilidad.



Unión modular definitiva preparada para el bloqueo.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO

Acople definitivo de los conos

- Confirme la estabilidad axial y rotacional del tallo y la anteversión. Rosque completamente la varilla, coloque el insertor/extractor y el cabezal de bloqueo. La línea de control debe quedar visible en la ventana. Ajuste el cabezal hasta contactar la pieza en T.

Aplicación del torque

Coloque la llave dinamométrica sobre el cabezal. Sitúe el mango antirrotacional medialmente sobre el yunque y úselo como apoyo para no transmitir fuerza al hueso. Accione la llave hasta oír el clic que indica el límite de torque. Para desmontar el cabezal utilice siempre la llave dinamométrica y mantenga la contrafuerza.



Mango antirrotacional: aplique contratorque sin cargar el hueso.



Línea de control visible antes de aplicar el torque.



Coloque la llave dinamométrica sobre el cabezal de bloqueo.



Accione la llave hasta oír el clic de torque.



Configuración completa para el acople cónico definitivo.



La referencia de la ventana confirma el montaje correcto.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO - SECUENCIA VISUAL



Mantenga el mango de apoyo estable durante el ajuste.



Sentido de ajuste del cabezal con contrafuerza aplicada.



Use la llave dinamométrica también para el desmontaje.



Sentido de aflojado para retirar el cabezal.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO

Inserción del tornillo definitivo

- Coloque el tornillo de bloqueo por la parte superior del cuerpo proximal. Acople la llave dinamométrica al destornillador de bloqueo de 5 mm. El mango antirrotacional debe orientarse con la marca «UP» del mismo lado que el tornillo; su camisa plástica protege el cono.

Ajuste y eventual retiro

Ajuste hasta oír el clic de la llave y use el mango antirrotacional como contratorque para no cargar el hueso. Puede emplearse el destornillador largo. Si debe retirarse el tornillo, use nuevamente la llave y el mango antirrotacional. Un tornillo que ya fue ajustado no debe reutilizarse.



Inserte el tornillo definitivo por el cuerpo proximal.



Acople la llave al destornillador de bloqueo de 5 mm.



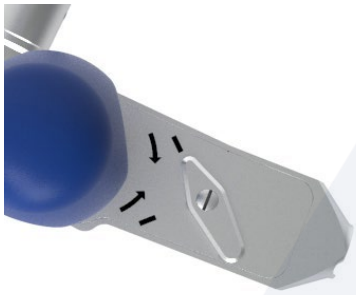
Posicione el tornillo sin dañar la rosca del cuerpo.



Aplique torque con el mango antirrotacional en apoyo.



Utilice la misma configuración sobre el implante aislado.



Sentido de ajuste indicado en la llave dinamométrica.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO - SECUENCIA VISUAL



Conecte el destornillador al tornillo de bloqueo.



Mantenga protegida la superficie del cono durante el ajuste.



Orientación UP: la marca debe quedar del lado del tornillo.



Ajuste hasta oír el clic, sin transmitir carga al hueso.



Sentido de retiro del tornillo con contratorque.



Destornillador largo: alternativa para el acceso profundo.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA IN VIVO

Cabeza femoral y reducción final

• Realice una nueva reducción de prueba para confirmar la cabeza definitiva. Las cabezas metálicas XL y XXL incorporan collar y pueden reducir el arco de movilidad; pruébelas siempre. Limpie el cono, coloque la cabeza y impacte únicamente con el impactor plástico específico. Reduzca la cadera.

Dispositivo de mesa: preparación

• La alternativa de mesa permite ensamblar los componentes antes de la implantación. Inspeccione las superficies, irrigue y seque la unión cónica. Coloque el dispositivo en el espacio previsto de la bandeja, seleccione el inserto correspondiente al tamaño distal e introduzca el tallo. Acople manualmente el cuerpo proximal.



Confirme el bloqueo definitivo antes de colocar la cabeza.



Retire el instrumental de torque del implante.



Respete el sentido de desmontaje de la llave.



Coloque el tallo en el inserto del dispositivo de mesa.



Acople manualmente el cuerpo proximal sobre la mesa.

IMPLANTACIÓN CON DISPOSITIVO DE MESA

Ensamblaje extracorpóreo y colocación definitiva

IMPLANTACIÓN CON DISPOSITIVO DE MESA

Acople cónico sobre la mesa

• Rosque la varilla, coloque el insertor/extractor y el cabezal. Confirme la línea de montaje en la ventana. Aplique la llave dinamométrica y use el mango antirrotacional sobre el yunque. Accione hasta oír el clic que confirma el torque de acople. Retire el instrumental con la llave en sentido contrario.



Seleccione el inserto compatible con el tamaño distal.



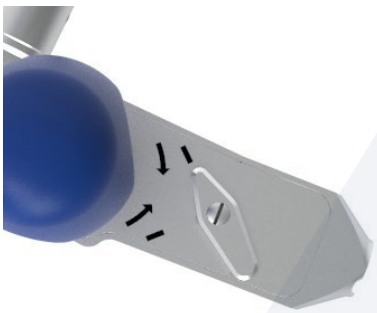
Monte varilla, insertor/extractor y cabezal de bloqueo.



Confirme la línea de montaje en la ventana.



Aplique torque con el dispositivo firmemente apoyado.



Afloje el cabezal con la llave y contrafuerza.

IMPLANTACIÓN CON DISPOSITIVO DE MESA

Tornillo definitivo sobre la mesa

- Introduzca el tornillo en el cuerpo proximal y monte la llave sobre el destornillador. Oriente la marca «UP» del mango antirrotacional hacia el tornillo; la camisa plástica debe proteger el cono durante el ajuste.



Introduzca el tornillo definitivo en el cuerpo proximal.



Estabilice el implante en el dispositivo de mesa.



Ajuste la llave en el sentido indicado.



Monte el destornillador y el mango antirrotacional.



Proteja el cono con la camisa plástica del mango.



La marca UP debe orientarse hacia el tornillo.

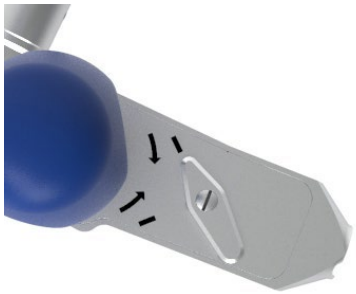
IMPLANTACIÓN CON DISPOSITIVO DE MESA

Ajuste y extracción del dispositivo

Ajuste el tornillo hasta el clic de la llave, siempre con contratorque. Puede utilizarse el destornillador largo. Si se retira el tornillo, no lo reutilice. Si el implante queda retenido en el dispositivo de mesa, use el tornillo extractor y, si necesita contratorque adicional, el destornillador de 3,5 mm.



Ajuste el tornillo hasta oír el clic de torque.



Mantenga el contratorque durante toda la maniobra.



Use el destornillador largo cuando el acceso lo requiera.



Retire el tornillo con llave dinamométrica y contrafuerza.



Respete el sentido de aflojado indicado.



Libere el implante retenido con el tornillo extractor.

IMPLANTACIÓN CON DISPOSITIVO DE MESA

Inserción del conjunto y reducción final

- Introduzca manualmente el implante ensamblado en el fémur. Utilice el impactor para alcanzar la profundidad y la anteversión previstas. Repita la reducción de prueba, limpie el cono e impacte la cabeza definitiva con el impactor plástico. Como alternativa puede utilizarse el mango del cuerpo proximal con yunque, excepto con cuerpos de longitud L40.



Introduzca manualmente el implante ensamblado en el fémur.



Impacte axialmente hasta alcanzar la profundidad prevista.



Controle la anteversión durante la impactación.



Impactor del cuerpo proximal para el asentamiento final.



Mango con yunque: alternativa excepto en cuerpos L40.

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Referencias, dimensiones y configuraciones

CUERPOS PROXIMALES

Cuerpos proximales - referencias 1 a 24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CCD	A	B	C	D	Ø E
01.22.001	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 40 mm STD	132°	50	39	37	35,4	20
01.22.002	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 50 mm STD	132°	60	49	37	35,4	20
01.22.003	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 60 mm STD	132°	70	59	37	35,4	20
01.22.004	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 70 mm STD	132°	80	69	37	35,4	20
01.22.005	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 80 mm STD	132°	90	79	37	35,4	20
01.22.006	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 90 mm STD	132°	100	89	37	35,4	20
01.22.007	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 40 mm LAT	132°	50	39	43	39,65	20
01.22.008	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 50 mm LAT	132°	60	49	43	39,65	20
01.22.009	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 60 mm LAT	132°	70	59	43	39,65	20
01.22.010	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 70 mm LAT	132°	80	69	43	39,65	20
01.22.011	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 80 mm LAT	132°	90	79	43	39,65	20
01.22.012	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 90 mm LAT	132°	100	89	43	39,65	20
01.22.021	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 40 mm STD	132°	50	39	37	35,4	24
01.22.022	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 50 mm STD	132°	60	49	37	35,4	24
01.22.023	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 60 mm STD	132°	70	59	37	35,4	24
01.22.024	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 70 mm STD	132°	80	69	37	35,4	24
01.22.025	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 80 mm STD	132°	90	79	37	35,4	24
01.22.026	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 90 mm STD	132°	100	89	37	35,4	24
01.22.027	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 40 mm LAT	132°	50	39	43	39,65	24
01.22.028	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 50 mm LAT	132°	60	49	43	39,65	24
01.22.029	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 60 mm LAT	132°	70	59	43	39,65	24
01.22.030	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 70 mm LAT	132°	80	69	43	39,65	24
01.22.031	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 80 mm LAT	132°	90	79	43	39,65	24
01.22.032	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 90 mm LAT	132°	100	89	43	39,65	24

I: bajo pedido. El tornillo de bloqueo se suministra con el cuerpo proximal.

CUERPOS PROXIMALES

Cuerpos proximales - referencias 25 a 48

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CCD	A	B	C	D	Ø E
01.22.041I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 40 mm STD	132°	50	39	37	35,4	28
01.22.042I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 50 mm STD	132°	60	49	37	35,4	28
01.22.043I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 60 mm STD	132°	70	59	37	35,4	28
01.22.044I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 70 mm STD	132°	80	69	37	35,4	28
01.22.045I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 80 mm STD	132°	90	79	37	35,4	28
01.22.046I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 90 mm STD	132°	100	89	37	35,4	28
01.22.047I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 40 mm LAT	132°	50	39	43	39,65	28
01.22.048I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 50 mm LAT	132°	60	49	43	39,65	28
01.22.049I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 60 mm LAT	132°	70	59	43	39,65	28
01.22.050I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 70 mm LAT	132°	80	69	43	39,65	28
01.22.051I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 80 mm LAT	132°	90	79	43	39,65	28
01.22.052I	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 90 mm LAT	132°	100	89	43	39,65	28
01.22.061I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 40 mm STD	132°	50	39	37	35,4	32
01.22.062I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 50 mm STD	132°	60	49	37	35,4	32
01.22.063I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 60 mm STD	132°	70	59	37	35,4	32
01.22.064I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 70 mm STD	132°	80	69	37	35,4	32
01.22.065I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 80 mm STD	132°	90	79	37	35,4	32
01.22.066I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 90 mm STD	132°	100	89	37	35,4	32
01.22.067I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 40 mm LAT	132°	50	39	43	39,65	32
01.22.068I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 50 mm LAT	132°	60	49	43	39,65	32
01.22.069I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 60 mm LAT	132°	70	59	43	39,65	32
01.22.070I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 70 mm LAT	132°	80	69	43	39,65	32
01.22.071I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 80 mm LAT	132°	90	79	43	39,65	32
01.22.072I	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 90 mm LAT	132°	100	89	43	39,65	32

I: bajo pedido. El tornillo de bloqueo se suministra con el cuerpo proximal.

CUERPOS PROXIMALES CON ORIFICIOS

Cuerpos proximales con orificios - referencias 1 a 24

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CCD	A	B	C	D	Ø E
01.22.401	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 40 mm STD con orificios	132°	50	39	37	35,4	20
01.22.402	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 50 mm STD con orificios	132°	60	49	37	35,4	20
01.22.403	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 60 mm STD con orificios	132°	70	59	37	35,4	20
01.22.404	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 70 mm STD con orificios	132°	80	69	37	35,4	20
01.22.405	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 80 mm STD con orificios	132°	90	79	37	35,4	20
01.22.406	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 90 mm STD con orificios	132°	100	89	37	35,4	20
01.22.407	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 40 mm LAT con orificios	132°	50	39	43	39,65	20
01.22.408	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 50 mm LAT con orificios	132°	60	49	43	39,65	20
01.22.409	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 60 mm LAT con orificios	132°	70	59	43	39,65	20
01.22.410	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 70 mm LAT con orificios	132°	80	69	43	39,65	20
01.22.411	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 80 mm LAT con orificios	132°	90	79	43	39,65	20
01.22.412	Cuerpo proximal Ø 20 mm L 90 mm LAT con orificios	132°	100	89	43	39,65	20
01.22.421	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 40 mm STD con orificios	132°	50	39	37	35,4	24
01.22.422	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 50 mm STD con orificios	132°	60	49	37	35,4	24
01.22.423	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 60 mm STD con orificios	132°	70	59	37	35,4	24
01.22.424	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 70 mm STD con orificios	132°	80	69	37	35,4	24
01.22.425	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 80 mm STD con orificios	132°	90	79	37	35,4	24
01.22.426	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 90 mm STD con orificios	132°	100	89	37	35,4	24
01.22.427	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 40 mm LAT con orificios	132°	50	39	43	39,65	24
01.22.428	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 50 mm LAT con orificios	132°	60	49	43	39,65	24
01.22.429	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 60 mm LAT con orificios	132°	70	59	43	39,65	24
01.22.430	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 70 mm LAT con orificios	132°	80	69	43	39,65	24
01.22.431	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 80 mm LAT con orificios	132°	90	79	43	39,65	24
01.22.432	Cuerpo proximal Ø 24 mm L 90 mm LAT con orificios	132°	100	89	43	39,65	24

El tornillo de bloqueo se suministra con el cuerpo proximal.

CUERPOS PROXIMALES CON ORIFICIOS

Cuerpos proximales con orificios - referencias 25 a 48

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CCD	A	B	C	D	Ø E
01.22.441	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 40 mm STD con orificios	132°	50	39	37	35,4	28
01.22.442	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 50 mm STD con orificios	132°	60	49	37	35,4	28
01.22.443	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 60 mm STD con orificios	132°	70	59	37	35,4	28
01.22.444	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 70 mm STD con orificios	132°	80	69	37	35,4	28
01.22.445	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 80 mm STD con orificios	132°	90	79	37	35,4	28
01.22.446	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 90 mm STD con orificios	132°	100	89	37	35,4	28
01.22.447	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 40 mm LAT con orificios	132°	50	39	43	39,65	28
01.22.448	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 50 mm LAT con orificios	132°	60	49	43	39,65	28
01.22.449	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 60 mm LAT con orificios	132°	70	59	43	39,65	28
01.22.450	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 70 mm LAT con orificios	132°	80	69	43	39,65	28
01.22.451	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 80 mm LAT con orificios	132°	90	79	43	39,65	28
01.22.452	Cuerpo proximal Ø 28 mm L 90 mm LAT con orificios	132°	100	89	43	39,65	28
01.22.461	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 40 mm STD con orificios	132°	50	39	37	35,4	32
01.22.462	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 50 mm STD con orificios	132°	60	49	37	35,4	32
01.22.463	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 60 mm STD con orificios	132°	70	59	37	35,4	32
01.22.464	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 70 mm STD con orificios	132°	80	69	37	35,4	32
01.22.465	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 80 mm STD con orificios	132°	90	79	37	35,4	32
01.22.466	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 90 mm STD con orificios	132°	100	89	37	35,4	32
01.22.467	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 40 mm LAT con orificios	132°	50	39	43	39,65	32
01.22.468	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 50 mm LAT con orificios	132°	60	49	43	39,65	32
01.22.469	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 60 mm LAT con orificios	132°	70	59	43	39,65	32
01.22.470	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 70 mm LAT con orificios	132°	80	69	43	39,65	32
01.22.471	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 80 mm LAT con orificios	132°	90	79	43	39,65	32
01.22.472	Cuerpo proximal Ø 32 mm L 90 mm LAT con orificios	132°	100	89	43	39,65	32

El tornillo de bloqueo se suministra con el cuerpo proximal.

TALLOS DISTALES

Tallos distales - referencias 1 a 26

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	L (mm)	G (mm)
01.22.101	Tallo distal Ø 12 mm L 140 mm	140	12
01.22.102	Tallo distal Ø 13 mm L 140 mm	140	13
01.22.103	Tallo distal Ø 14 mm L 140 mm	140	14
01.22.104	Tallo distal Ø 15 mm L 140 mm	140	15
01.22.105	Tallo distal Ø 16 mm L 140 mm	140	16
01.22.106	Tallo distal Ø 17 mm L 140 mm	140	17
01.22.107	Tallo distal Ø 18 mm L 140 mm	140	18
01.22.108	Tallo distal Ø 19 mm L 140 mm	140	19
01.22.109	Tallo distal Ø 20 mm L 140 mm	140	20
01.22.110	Tallo distal Ø 21 mm L 140 mm	140	21
01.22.111	Tallo distal Ø 22 mm L 140 mm	140	22
01.22.112I	Tallo distal Ø 23 mm L 140 mm	140	23
01.22.113I	Tallo distal Ø 24 mm L 140 mm	140	24
01.22.114I	Tallo distal Ø 25 mm L 140 mm	140	25
01.22.115I	Tallo distal Ø 26 mm L 140 mm	140	26
01.22.116I	Tallo distal Ø 27 mm L 140 mm	140	27
01.22.117I	Tallo distal Ø 28 mm L 140 mm	140	28
01.22.131	Tallo distal Ø 12 mm L 180 mm	180	12
01.22.132	Tallo distal Ø 13 mm L 180 mm	180	13
01.22.133	Tallo distal Ø 14 mm L 180 mm	180	14
01.22.134	Tallo distal Ø 15 mm L 180 mm	180	15
01.22.135	Tallo distal Ø 16 mm L 180 mm	180	16
01.22.136	Tallo distal Ø 17 mm L 180 mm	180	17
01.22.137	Tallo distal Ø 18 mm L 180 mm	180	18
01.22.138	Tallo distal Ø 19 mm L 180 mm	180	19
01.22.139	Tallo distal Ø 20 mm L 180 mm	180	20

I: bajo pedido.

TALLOS DISTALES

Tallos distales - referencias 27 a 51

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	L (mm)	G (mm)
01.22.140	Tallo distal Ø 21 mm L 180 mm	180	21
01.22.141	Tallo distal Ø 22 mm L 180 mm	180	22
01.22.142I	Tallo distal Ø 23 mm L 180 mm	180	23
01.22.143I	Tallo distal Ø 24 mm L 180 mm	180	24
01.22.144I	Tallo distal Ø 25 mm L 180 mm	180	25
01.22.145I	Tallo distal Ø 26 mm L 180 mm	180	26
01.22.146I	Tallo distal Ø 27 mm L 180 mm	180	27
01.22.147I	Tallo distal Ø 28 mm L 180 mm	180	28
01.22.161	Tallo distal Ø 12 mm L 220 mm	220	12
01.22.162	Tallo distal Ø 13 mm L 220 mm	220	13
01.22.163	Tallo distal Ø 14 mm L 220 mm	220	14
01.22.164	Tallo distal Ø 15 mm L 220 mm	220	15
01.22.165	Tallo distal Ø 16 mm L 220 mm	220	16
01.22.166	Tallo distal Ø 17 mm L 220 mm	220	17
01.22.167	Tallo distal Ø 18 mm L 220 mm	220	18
01.22.168	Tallo distal Ø 19 mm L 220 mm	220	19
01.22.169	Tallo distal Ø 20 mm L 220 mm	220	20
01.22.170	Tallo distal Ø 21 mm L 220 mm	220	21
01.22.171	Tallo distal Ø 22 mm L 220 mm	220	22
01.22.172I	Tallo distal Ø 23 mm L 220 mm	220	23
01.22.173I	Tallo distal Ø 24 mm L 220 mm	220	24
01.22.174I	Tallo distal Ø 25 mm L 220 mm	220	25
01.22.175I	Tallo distal Ø 26 mm L 220 mm	220	26
01.22.176I	Tallo distal Ø 27 mm L 220 mm	220	27
01.22.177I	Tallo distal Ø 28 mm L 220 mm	220	28

I: bajo pedido.

LONGITUD, BLOQUEO Y SISTEMA DE REVISIÓN

Longitud total del implante

CUERPO PROXIMAL	L 140 mm	L 180 mm	L 220 mm
40 STD	192,6	232,6	272,6
50 STD	202,6	242,6	282,6
60 STD	212,6	252,6	292,6
70 STD	222,6	262,6	302,6
80 STD	232,6	272,6	312,6
90 STD	242,6	282,6	322,6
40 LAT	192,6	232,6	272,6
50 LAT	202,6	242,6	282,6
60 LAT	212,6	252,6	292,6
70 LAT	222,6	262,6	302,6
80 LAT	232,6	272,6	312,6
90 LAT	242,6	282,6	322,6

Tornillo de bloqueo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
01.22.201	Tornillo de bloqueo

El tornillo de bloqueo se suministra con el cuerpo proximal.

Sistema de cabezas con camisa para revisión

DIÁMETRO	REF. CABEZA	TAMAÑO CAMISA	REF. CAMISA
Ø 28	01.29.230H	S	01.29.240A
Ø 32	01.29.231H	M	01.29.241A
Ø 36	01.29.232H	L	01.29.242A
Ø 40	01.29.233H	XL	01.29.243A

Configuraciones específicas para cirugía de revisión.

CABEZAS FEMORALES

Cabezas femorales

DIÁMETRO	TAMAÑO	INOX.	CoCr	CERÁMICA DELTA	CERÁMICA OPTION	CERÁMICA REV.
Ø 22	S	01.25.130 I	01.25.124 I	-	-	-
Ø 22	M	25055.2203 I	01.25.123 I	-	-	-
Ø 28	S	25055.2801	01.25.011	38.49.7175.445.00	38.49.7176.935.81	01.29.201
Ø 28	M	25055.2803	01.25.012	38.49.7175.455.00	38.49.7176.935.82	01.29.202
Ø 28	L	25055.2805	01.25.013	38.49.7175.465.00	38.49.7176.935.85	01.29.203
Ø 28	XL	25055.2807	01.25.014	-	38.49.7176.935.84	-
Ø 28	XXL	25055.2810 I	01.25.015 I	-	-	-
Ø 32	S	25055.3201	01.25.021	38.49.7175.665.00	38.49.7176.945.81	01.29.204
Ø 32	M	25055.3203	01.25.022	38.49.7175.675.00	38.49.7176.945.82	01.29.205
Ø 32	L	25055.3205	01.25.023	38.49.7175.685.00	38.49.7176.945.85	01.29.206
Ø 32	XL	25055.3207	01.25.024	38.49.7181.345.00	38.49.7176.945.84	01.29.207
Ø 32	XXL	25055.3210 I	01.25.025 I	-	-	-
Ø 36	S	-	01.25.030	38.49.7179.275.00	38.49.7176.965.81	01.29.208
Ø 36	M	-	01.25.031	38.49.7179.285.00	38.49.7176.965.82	01.29.209
Ø 36	L	-	01.25.032	38.49.7179.295.00	38.49.7176.965.85	01.29.210
Ø 36	XL	-	01.25.033	38.49.7175.925.00	38.49.7176.965.84	01.29.211
Ø 36	XXL	-	01.25.034 I	-	-	-
Ø 40	S	-	-	38.49.7179.885.00 I	38.49.7179.815.81 I	01.29.212
Ø 40	M	-	-	38.49.7179.895.00 I	38.49.7179.815.82 I	01.29.213
Ø 40	L	-	-	38.49.7179.905.00 I	38.49.7179.815.85 I	01.29.214
Ø 40	XL	-	-	38.49.7179.915.00 I	38.49.7179.815.84 I	01.29.215

I: bajo pedido. Las referencias de la última columna corresponden a opciones específicas para revisión.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Condición de entrega

El instrumental se suministra no estéril. Debe limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave.

Proceso

- Aplique la normativa nacional vigente, las directivas regulatorias correspondientes y las instrucciones del fabricante del autoclave. Antes de procesar el instrumental, consulte las instrucciones de uso y el procedimiento validado de limpieza, descontaminación y esterilización del fabricante del dispositivo.

Control previo al uso

Verifique limpieza, integridad, funcionamiento, articulaciones, roscas, superficies de acople y ausencia de daño o corrosión. No utilice instrumental que presente deterioro o cuyo desempeño sea incierto.

RESPONSABILIDAD DEL CENTRO

Utilizar ciclos validados y trazables.

Respetar la configuración de carga del autoclave.

Registrar los controles del proceso y la liberación.

Mantener el instrumental protegido hasta su uso.

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Este documento es una recreación editorial y traducción técnica del documento de referencia. No sustituye el juicio clínico, la capacitación específica, las instrucciones de uso vigentes ni la documentación regulatoria aplicable. La indicación, selección de componentes y técnica final son responsabilidad del equipo tratante.

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

@chacoimplanteok

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: M-Vizion Surgical Technique
REFERENCIA DOCUMENTAL: 99.66.12
REVISIÓN: 06
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: April 2022
FABRICANTE: Medacta International SA
MARCADO: CE 0476